

ЧЕК-ЛИСТ

Осмотр ребёнка

Pediatric Assessment Triangle, ABCDE, возрастные нормы



Последовательность: PAT без контакта, затем ABCDE, затем осмотр от головы к пяткам.

Витальные показатели интерпретируются относительно возрастной нормы.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.1 · 12 сентября 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

1. РАТ — от двери, до контакта, около 15 секунд

Внешний вид: тонус, реакция на окружающих, слежение взглядом, характер крика или речи, удаётся ли утешить. **Работа дыхания:** втяжения яремной ямки, межреберий, подреберий; раздувание крыльев носа; вынужденное положение; стридор; кряхтение. **Кожа:** цвет, мраморность, цианоз, бледность, сыпь. Итог — одна категория: стабилен / компенсирован / декомпенсирован. Отсутствие зрительного контакта при нормальных витальных показателях — неблагоприятный признак.

2. ABCDE

А — содержимое полости рта, слюнотечение, положение, признаки инородного тела. **В** — ЧД подсчётом за 30–60 с, аускультация в шести точках, симметрия экскурсии, SpO_2 . **С** — ЧСС, центральный и периферический пульс, капиллярное наполнение (норма < 2 с), АД, температура кистей и стоп. **Д** — сознание, зрачки, **глюкоза у каждого ребёнка**, менингеальные знаки, очаговая симптоматика, судороги. **Е** — кожа целиком, температура, сыпь, следы травмы, гигиена.

3. Возрастные нормы в покое, в бодрствовании

Возраст	ЧСС	ЧД	Нижняя граница САД
Новорождённый	110–160	30–50	> 60
1–12 мес	100–150	25–40	> 70
1–2 года	90–140	22–35	> 70 + 2 × возраст
3–5 лет	80–130	20–30	> 70 + 2 × возраст
6–11 лет	70–110	18–25	> 70 + 2 × возраст
12 лет и старше	60–100	12–20	> 90

$SpO_2 \geq 95\%$. Гипогликемия: у ребёнка < 3,0 ммоль/л, у новорождённого < 2,6 ммоль/л.

Тахикардия — самый ранний признак декомпенсации. Гипотензия появляется последней и означает срыв компенсации. Повторный подсчёт через 10 минут в спокойной обстановке: стрессовая тахикардия уменьшается, патологическая сохраняется. Дифференциал: боль, страх, лихорадка, дегидратация, анемия, гипоксия, гиповолемия, нейролептики и β -агонисты, тиреотоксикоз, аритмия, интоксикация.

4. Дегидратация — пять признаков

Слизистые языка и внутренней поверхности губы · капиллярное наполнение > 2 с · тургор на животе или бедре · западение орбит и наличие слёз при плаче · время и объём последнего мочеиспускания. Дополнительно: родничок у младенца, масса тела до заболевания. Внешний вид сам по себе недостаточен.

5. Осмотр от головы к пяткам — порядок фиксированный

Голова (родничок, гематомы, зрачки, симметрия лица) · глаза, уши, нос · ротоглотка (**при подозрении на эпиглоттит насильственный осмотр не выполняется**) · лимфатические узлы · шея и менингеальные знаки · грудная клетка · живот (лёжа, тёплыми руками, с безболезненного участка) · **наружные половые органы и перианальная область — входят в стандарт**, перекут яичка выявляется только при осмотре мошонки · кожа целиком (петехии, не бледнеющие при диаскопии, — менингококцемия) · конечности и позвоночник · неврологический минимум.

6. Анамнез

Жалоба и точное время начала · препараты, введённые до приезда, включая данные родственниками: название, доза, время · аллергия · хронические заболевания и наблюдение · постоянная терапия с упаковок · вакцинация по возрасту · последний приём пищи и жидкости, мочеиспускание и стул · контакты по инфекции, поездки, детское учреждение.

Безнадзорный ребёнок. Полный осмотр кожи с описанием каждого кровоподтёка: локализация, размер, цвет, форма. Кровоподтёки на закрытых участках, на разных стадиях заживления и с отпечатком предмета — маркеры физического насилия. Температура, глюкоза и SpO_2 измеряются полностью независимо от внешнего впечатления: карта вызова может оказаться единственным медицинским документом на этого ребёнка за сутки. Отдельно — хронические заболевания без лечения: эпилепсия без противосудорожных, диабет без инсулина, психиатрический диагноз без поддерживающей терапии.

Pediatric Assessment Triangle

Оценка от двери, до тактильного контакта, около 15 с.

Вершина	Содержание
Внешний вид (Appearance)	Мышечный тонус, реакция на окружающих, слежение взглядом, характер крика или речи, возможность утешить
Работа дыхания	Втяжения яремной ямки, межреберий и подреберий; раздувание крыльев носа; вынужденное положение (ортопноэ, «нюхательное», трипод); стридор; экспираторное кряхтение (grunting); участие мышц живота
Кровообращение по коже	Цвет, мраморность, цианоз, бледность, сыпь

Отсутствие зрительного контакта при формально сохранённых витальных показателях является неблагоприятным признаком.

Итог ПАТ формулируется одной категорией: стабилен / компенсирован / декомпенсирован. Категория определяет темп дальнейшего осмотра и объём вмешательства.

ABCDE

- **A.** Проходимость дыхательных путей: содержимое полости рта, слюнотечение, положение, признаки инородного тела.
- **B.** Частота дыхания (подсчёт 30–60 с, не 15 с), аускультация в шести точках, симметрия экскурсии, SpO₂.
- **C.** Частота сердечных сокращений, центральный и периферический пульс, капиллярное наполнение (норма < 2 с), артериальное давление, температура кожи кистей и стоп.
- **D.** Сознание (AVPU или педиатрическая ШКГ), зрачки, глюкоза у каждого ребёнка, менингеальные знаки, очаговая неврологическая симптоматика, судороги в анамнезе вызова.
- **E.** Полный осмотр кожи, температура тела, сыпь, следы травмы, гигиеническое состояние.

Возрастные нормы в покое, в бодрствовании

Возраст	ЧСС, в минуту	ЧД, в минуту	Нижняя граница САД, мм рт. ст.
Новорождённый	110-160	30-50	> 60
1-12 мес	100-150	25-40	> 70
1-2 года	90-140	22-35	> 70 + 2 × возраст (годы)
3-5 лет	80-130	20-30	> 70 + 2 × возраст (годы)
6-11 лет	70-110	18-25	> 70 + 2 × возраст (годы)
12 лет и старше	60-100	12-20	> 90

Нижняя граница систолического давления в возрасте 1-10 лет: САД = 70 + возраст (годы) × 2. SpO₂ ≥ 95 %. Гипогликемия: у ребёнка < 3,0 ммоль/л, у новорождённого < 2,6 ммоль/л.

Тахикардия — наиболее ранний признак декомпенсации у ребёнка. Гипотензия появляется последней и означает срыв компенсации. Частота 120 в минуту у ребёнка 12 лет выходит за возрастную норму и требует объяснения.

Дифференциал тахикардии на месте: боль, страх, лихорадка, дегидратация, анемия, гипоксия, гиповолемия, лекарственные средства (нейролептики, β-агонисты, атропин), тиреотоксикоз, аритмия, интоксикация. Повторный подсчёт через 10 минут в спокойной обстановке: стрессовая тахикардия уменьшается, патологическая сохраняется.

Дегидратация

Внешний вид недостаточен, в том числе у детей с дефицитом массы тела и у получающих нейролептики. Оцениваются пять признаков:

1. Слизистые оболочки (язык и внутренняя поверхность губы).
2. Капиллярное наполнение > 2 с.
3. Тургор кожи на животе или бедре.
4. Глаза: западение орбит; наличие слёз при плаче.
5. Диурез по расспросу: время и объём последнего мочеиспускания.

Дополнительно: состояние родничка у младенца; масса тела до заболевания и на момент осмотра, если известна.

Осмотр от головы к пяткам

Последовательность фиксированная.

- **Голова.** Родничок, гематомы, зрачки, симметрия лица.
- **Глаза, уши, нос.** Отделяемое, гиперемия, инородные тела.
- **Ротоглотка.** Зубы, налёты, гиперемия, величина миндалин, тризм, слюнотечение. При клиническом подозрении на эпиглоттит насильственный осмотр полости рта не выполняется.
- **Лимфатические узлы.** Шейные, подчелюстные, подмышечные, паховые.
- **Шея.** Ригидность затылочных мышц, менингеальные знаки, объём движений.

- **Грудная клетка.** Экскурсия, деформации, аускультация лёгких, тоны сердца.
- **Живот.** Консистенция, болезненность, перитонеальные знаки, размеры печени и селезёнки, перистальтика, вздутие. Пальпация лёжа, тёплыми руками, начиная с безболезненного участка.
- **Наружные половые органы и перианальная область.** Осмотр входит в стандарт, в том числе при болях в животе (перекрут яичка у мальчика диагностируется только при осмотре мошонки) и у безнадзорного ребёнка.
- **Кожа целиком.** Сыпь (петехии, не бледнеющие при диаскопии, — признак менингококцемии), кровоподтёки, ожоги, следы инъекций, гигиена, педикулёз, состояние ногтей.
- **Конечности и позвоночник.** Деформации, объём движений, болезненность, симметрия.
- **Неврологический минимум.** Тонус, походка, проба Ромберга (по возрасту), координация, чувствительность, менингеальные знаки.

Анамнез

1. Жалоба и точное время начала.
2. Препараты, уже введённые до приезда бригады: название, доза, время, включая средства, данные родственниками.
3. Аллергия.
4. Хронические заболевания, диспансерное наблюдение, инвалидность.
5. Постоянная терапия: названия и дозы с упаковок, не со слов.
6. Вакцинация по возрасту; наличие отказа.
7. Последний приём пищи и жидкости, последнее мочеиспускание и стул — время и объём.
8. Контакты по инфекции, поездки, посещение детского учреждения.

У ребёнка, получающего психотропные средства, отдельно фиксируются препарат, доза и факт недавнего изменения схемы. Нейролептики вызывают тахикардию, задержку мочи, сухость слизистых, гипертермию, удлинение интервала QT и острую дистонию. При подозрении на осложнение нейролептической терапии выполняется ЭКГ.

Безнадзорный ребёнок

Осмотр в отделе полиции, приюте или на улице дополняется данными, необходимыми для последующей документации.

- Полный осмотр кожи. Каждый кровоподтёк и ссадина описываются: локализация, размер, цвет, форма. Кровоподтёки на закрытых участках тела, на разных стадиях заживления и с отпечатком предмета являются маркерами физического насилия.
- Признаки заброшенности: гигиена, соответствие одежды погоде, педикулёз, кариес, дефицит массы тела.
- Температура тела, глюкоза и SpO₂ измеряются в полном объёме независимо от внешнего впечатления: карта вызова может быть единственным медицинским документом на этого ребёнка за текущие сутки.
- Хронические заболевания и препараты, которые ребёнок не получает (эпилепсия без противосудорожной терапии, сахарный диабет без инсулина, психиатрический диагноз без поддерживающего лечения), составляют частую непосредственную угрозу у беспризорного.

- Психический статус: ориентация, контакт, адекватность, признаки интоксикации, суицидальные высказывания.
- Запись в карте выполняется с детализацией, достаточной для последующих организационных решений, в том числе принимаемых лицами без медицинского образования.

Источники

- Алгоритмы оказания скорой медицинской помощи, Москва, 2025 — педиатрические разделы (возрастные нормы артериального давления, дозирование по массе тела).
- PALS / ERC Paediatric Life Support — Pediatric Assessment Triangle, возрастные нормы витальных показателей.
- Oxford Handbook of Emergency Medicine — Paediatric emergencies.
- APLS: The Practical Approach — оценка дегидратации и признаки шока у детей.